SDD 016 Sujet n°1

Spécialité : hématologie

Date : 22/08/2024
Auteur : Hélène RUBIN (DES néphrologie)
Relecteur(s) : Lucie-Lou VIAL (DES MAR, EN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie diagnostique
Item(s) en lien avec la station	Item n° 220 – Adénopathies superficielles Item n° 318 – LLC
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 016 - Adénopathie unique ou multiple
Matériel nécessaire à la station	Table, chaise, stylo
Contexte de la station	Patient/e de 79 ans qui consulte pour des adénopathies cervicales et axillaires "des boules" apparues il y a 3 mois.

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne en hématologie en 2e semestre, et vous recevez en consultation M. ou Mme P. MICHEL, 79 ans, pour des « boules » apparues au niveau du cou et des aisselles. Le médecin traitant a prescrit une numération formule sanguine que le patient vous a rapporté (document en annexe).

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour :
- Réaliser l'interrogatoire ciblé du patient.
- Décrire ce que vous recherchez à l'examen [1][2]clinique dans ce contexte

Vous ne devez pas :
- Réaliser un examen clinique sur le patient.
- Prescrire des examens complémentaires.
- Réaliser une prise en charge thérapeutique.

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)	
Se renseigne sur le mode de vie du patient : voyage récent en zone tropicale, toxicomanie intraveineuse, rapports sexuels à risque, animaux à domicile, loisirs en extérieur (au moins 2)	1 pt
Recherche d'une immunodépression : prise d'immunosuppresseur ou corticoïdes au long cours, ATCD de splénectomie, VIH, DICV (au moins 1)	1pt
Recherche un antécédent néoplasique (cancer solide ou hémopathie)	1pt
Recherche une introduction récente de médicament.	1 pt
Recherche au moins 1 un facteur déclenchant (exemple : épisode infectieux, piqûre d'insecte, griffure par un animal, contage récent, rapport sexuel à risque)	1 pt
Interroge le patient sur la présence de signes généraux : fièvre, asthénie, anorexie, amaigrissement, prurit (au moins 4/5).	1 pt
Explique que son examen clinique recherchera les caractéristiques des adénopathies (au moins 3/4) : - Uni- ou bilatérales ? - Symétriques ou non ? - Douloureuses - Taille ?	1 pt
Énonce palper les aires ganglionnaires : - axillaire - sus-claviculaire - inguinal - occipital	1 pt
Explique palper les adénopathies pour rechercher leur caractère ferme ou rénitent	1 pt
Explique inspecter les adénopathies pour rechercher des érythèmes	1 pt
Explique qu'il va rechercher la présence d'hépatomégalie ET de splénomégalie	1 pt
Communications et attitudes (max 5 grilles)	

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

9. APTITUDE À STRUCTURER L'EXAMEN CLINIQUE

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
L'examen clinique est incomplet et désorganisé ou ne fait pas l'examen clinique	Les éléments recherchés sont peu ciblés, s'attarde à des manœuvres inutiles	L'examen clinique est raisonnablement organisé et couvre les éléments essentiels	L'examen clinique suit un enchaînement logique et est centré sur le problème, il n'y a pas de manœuvre inutile	L'examen est réalisé sans erreur avec un but précis, démarche intégrée

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ[3]

Phrase de démarrage du patient simulé :

Ah bonjour docteur ! Mon médecin généraliste m'a conseillé de vous voir, j'ai pris mon bilan sanguin avec moi ! Est-ce qu'il faut que je m'inquiète ?

Identité du patient :

Taille : 1,78 m
Poids de référence : 70 kg
Poids mesuré la veille : 69 kg (perte de 1 kg en 3 mois)
IMC : 22 kg/m²

Mode de vie :

Profession : retraité, ancien responsable de projet dans un bureau d'études.
Marié, vit avec sa compagne dans un appartement dans le centre-ville de Paris.
2 filles de 49 et 45 ans ; 1 petit-fils de 10 ans ; 2 petites filles de 8 et 12 ans.

Logement propre. Pas d'animaux à domicile et pas de contact récent avec un animal.
Autonome dans les activités de la vie quotidienne.

Loisirs : Joue aux échecs, lecture, randonnées 3 fois par mois.
Dernier voyage : il y a 1 an dans le sud de la France.
Dernier voyage hors de France : au Maroc il y a 7 ans.

Tabac : sevré il y a 17 ans, a fumé 1 paquet par jour pendant 23 ans.
Alcool : 1 verre de vin le samedi et le dimanche midi.
Pas d'autres drogues, pas de toxicomanie intraveineuse.

Antécédents personnels :

Enfance : appendicectomie.
1963 : Hépatite A
2016 : Carcinome épidermoïde de la joue droite opéré, sans complication
2017 : Zona intercostal droit.

Antécédents familiaux :

Mère : Hypertension artérielle découverte à 61 ans.
Père : Non connu.
Fille de 49 ans : Colique néphrétique droite il y a 2 ans.
Fille de 45 ans : Thyroïdite d'Hashimoto diagnostiquée cette année.

Médicaments et vaccins :

Aucun traitement habituel.Vaccins : DTPCa à 75 ans, Grippe et Covid chaque année, pas de vaccination pneumocoque.

Allergies :

Pollen de bouleau (rhinite et conjonctivite). Pas d'allergie médicamenteuse.

Symptômes et signes physiques positifs :

- Légère asthénie, liée à une insomnie de main[4][5]tien, mais sans répercussion sur les AVQ.
- Perte de 1 kg en 3 mois.
- Sensation de pesanteur de l'hypochondre gauche, sans douleur.
- Adénopathies bilatérales et symétriques, de 1-2 cm, au niveau cervical et axillaire. Non compressives. Fermes et indolores, non inflammatoires, non pierreuses.
- Splénomégalie à 3 travers de doigt

Symptômes négatifs :

Pas de sueurs nocturnes, pas de prurit.
Pas d'hépatomégalie. Pas de douleur à l'ingestion d'alcool. Absence d'ictère.
Pas de bulle hémorragique intra-buccale, pas de purpura, pas d'ecchymose.

Pas d'infection récente, pas de contact avec un nourrisson, pas de contage.

Mode d'apparition, ancienneté et évolution des symptômes :

Apparition progressive en 2-3 mois, ne se souvient pas de la date précise. Depuis, persistance avec légère majoration de la taille.

Constantes :

T°C : 36,9°C.

Données complémentaires :

NFS du 17/04/24		NFS du 05/01/24	
Hématies	4,01 T/L	Hématies	5,76 T/L
Hémoglobine	13,0 g/dL	Hémoglobine	13,5 g/dL
Hématocrite	35,0 %	Hématocrite	35,5 %
VGM	89 fL	VGM	90 fL
CCMH	34,3 g/dL	CCMH	34,9 g/dL
Plaquettes	**145 G/L**	Plaquettes	210 G/L
Leucocytes	**12,10 G/L**	**Leucocytes**	**11,69 G/L**
PNN	4,53 G/L	PNN	5,04 G/L
PNE	0,40 G/L	PNE	0,30 G/L
PNB	0,01 G/L	PNB	0,01 G/L
Lymphocytes	**7,02 G/L**	**Lymphocytes**	**6,23 G/L**
Monocytes	0,14 G/L	Monocytes	0,12 G/L